GUIDE COMPLET

Arrêter de Fumer, *Autrement*

Comprendre la dépendance au tabac, et des pistes pour aborder l'arrêt autrement.



Alain Zenatti
Hypnothérapeute
NovaHypnose · Paris 4e · novahypnose.fr

AU PROGRAMME

Six chapitres, *une idée simple*

Comprendre ce que la cigarette fait vraiment, pourquoi la volonté seule ne suffit pas toujours, et préparer votre arrêt pas à pas.

01 Pourquoi fumez-vous vraiment ? La science de la dépendance

02 Les 3 profils du fumeur

03 Pourquoi la volonté seule ne suffit pas, et pourquoi c'est normal

04 Ce que la recherche dit de l'hypnose et de l'arrêt du tabac

05 Votre programme pratique : préparer votre arrêt

06 Quand consulter ? Ce que l'hypnothérapie peut faire pour vous

AVANT DE COMMENCER

Ce guide propose des pistes de réflexion. Il ne remplace ni un avis médical ni un suivi psychologique ou psychiatrique. Pour arrêter de fumer, vous pouvez aussi être accompagné(e) par votre médecin, un tabacologue, ou Tabac info service (39 89, du lundi au samedi). En cas de détresse, appelez le 3114.

INTRODUCTION

Vous voulez arrêter de fumer.

Peut-être depuis longtemps. Peut-être depuis hier.

Vous avez peut-être déjà essayé, une fois, deux fois, ou davantage : patchs, gommes, volonté pure, applications, promesses du 1er janvier. Et à chaque fois, à un moment ou à un autre, quelque chose a craqué.

Ce guide est fait pour vous. Pas pour vous donner une leçon sur les dangers du tabac, vous les connaissez déjà. Mais pour vous expliquer quelque chose que beaucoup de méthodes ne disent pas : ce n'est pas seulement une question de volonté.

Arrêter de fumer n'est pas qu'un combat à mener. C'est aussi une compréhension à avoir. Quand on comprend ce qui se passe dans le cerveau, ce que la cigarette fait réellement et ce qu'elle ne fait pas, quelque chose peut changer.

31,1 %
des 18-75 ans déclarent fumer en France hexagonale (Santé publique France, 2023)

23,1 %
fument quotidiennement (Santé publique France, 2023)

3 à 5 %
des personnes qui arrêtent seules restent abstinentes à 6-12 mois (Hughes et al., 2004)

CHAPITRE

01

Pourquoi fumez-vous vraiment ? *La science de la dépendance*

Votre cerveau n'est pas faible. Il a appris quelque chose.

Pendant des décennies, on a présenté la dépendance au tabac comme un manque de caractère. Cette vision est inexacte et nuisible : elle génère de la honte, et la honte est l'ennemie du changement. Voici ce qui se passe.

La dépendance physique : le circuit de la nicotine

Dès la première cigarette, la nicotine entre dans la circulation sanguine et atteint le cerveau en quelques secondes. Elle déclenche une libération de dopamine, la molécule liée au plaisir, à la récompense, à la motivation. Le cerveau enregistre : c'est bon, recommence.

Mais voici le piège : avec le temps, le cerveau devient plus sensible à la nicotine. Quand le taux de nicotine baisse, un signal d'inconfort apparaît, que l'on ressent comme l'envie de fumer. Ce que l'on appelle le « plaisir » de la cigarette est en grande partie le soulagement du manque que la cigarette a créé. Un non-fumeur n'a pas ce manque.

La dépendance psychologique : souvent plus tenace

Les symptômes physiques du sevrage sont surtout marqués dans les premiers jours, puis ils s'estompent sur quelques semaines. Ce qui dure, c'est la dépendance psychologique. Au fil des années, le cerveau a associé la cigarette à des dizaines de contextes : le café du matin, la pause après le déjeuner, la fin d'une journée difficile, la conversation entre collègues, l'attente devant une porte. Ces associations sont ancrées dans la partie automatique du cerveau, celle qui gère les réflexes, les habitudes, les réponses émotionnelles.

C'est pourquoi, même des mois après l'arrêt, l'odeur du café ou un verre de vin peut déclencher une envie intense. Pas parce que vous manquez de volonté, mais parce que votre cerveau a enregistré un signal conditionné.

> *« La nicotine crée le manque. Le manque crée la peur du manque. Et la peur du manque maintient le fumeur, pas les barreaux. »*
>
> Alain Zenatti

À RETENIR

La dépendance au tabac est double : physique (nicotine) et psychologique (associations conditionnées, souvent plus durables). Les méthodes qui ne s'adressent qu'à la dimension physique laissent de côté une partie du problème.

CHAPITRE

02

Les 3 profils *du fumeur*

Il n'existe pas « un » fumeur. Il en existe au moins trois, et comprendre lequel vous êtes aide à choisir votre approche.

Profil	Ce que vous ressentez	Ce que cache ce profil
1. Fumeur de détente, « Relaxation »	Vous fumez quand vous êtes stressé, tendu, surchargé. La cigarette est votre « soupape ».	La pause se substitue à la cigarette. La question : comment accéder au calme sans déclencheur conditionné ?
2. Fumeur d'habitude, « Automatisme »	Vous fumez par automatisme, sans y penser : après le café, au volant, en attendant.	La cigarette ponctue des transitions. La question : comment habiter ces espaces autrement ?
3. Fumeur identitaire, « Béquille sociale »	La cigarette fait partie de qui vous êtes : une façon de vous sentir à l'aise en société, de vous donner contenance.	La question : comment trouver cette solidité intérieure sans le support externe ?

> À RETENIR
>
> La plupart des fumeurs combinent deux ou trois profils. L'enjeu n'est pas de se coller une étiquette, mais de comprendre ce que la cigarette fait réellement pour vous : ce besoin est légitime, et il continuera d'exister après l'arrêt.

CHAPITRE

03

Pourquoi la volonté seule *ne suffit pas, et pourquoi c'est normal*

Une donnée que l'on dit rarement quand on se lance dans l'arrêt « sec » : avec la volonté seule, environ 3 à 5 % des tentatives aboutissent à une abstinence prolongée à 6-12 mois (Hughes et al., 2004).

Ce n'est pas parce que les fumeurs sont faibles : la volonté est souvent un outil insuffisant pour ce travail.

Le mythe de la volonté

La volonté est une ressource consciente, qui s'appuie sur le cortex préfrontal, la partie du cerveau qui planifie, raisonne, résiste. C'est la même ressource que vous utilisez pour tenir un régime ou un budget.

Or la dépendance au tabac s'appuie aussi sur des structures plus anciennes et plus rapides : le système limbique, les ganglions de la base, le circuit de la récompense. Ces systèmes ne parlent pas la langue de la raison, mais celle des associations, des émotions, des automatismes. Demander à la seule volonté de contrer la dépendance, c'est un peu comme demander de retenir sa respiration indéfiniment : on peut y arriver un moment.

L'effet des tentatives ratées

Chaque tentative qui échoue peut renforcer un récit : « Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter. » Ce récit devient lui-même un obstacle pour la tentative suivante. Plus on se bat contre l'envie, plus on lui donne d'importance. Ce que l'on accepte d'examiner peut changer.

Pistes utiles

- Comprendre le mécanisme de la dépendance change déjà quelque chose.
- Travailler sur les associations plutôt que sur la seule résistance à l'envie.
- Répondre aux besoins réels (calme, pause, appartenance) par d'autres moyens.
- S'appuyer sur un accompagnement : médecin, tabacologue, et si vous le souhaitez, hypnothérapie.

> *« Le fumeur qui réussit à arrêter n'a pas forcément plus de volonté que les autres. Il a trouvé une façon de moins en avoir besoin. »*
>
> Alain Zenatti

CHAPITRE

04

Ce que la recherche dit *de l'hypnose et de l'arrêt du tabac*

L'hypnose n'est pas de la magie. C'est un état de concentration et de réceptivité, étudié en laboratoire.

Qu'est-ce que l'état hypnotique ?

C'est un état naturel que vous connaissez déjà : quand vous êtes absorbé dans un film, un livre, ou une tâche qui vous captive. L'esprit devient plus réceptif, la critique consciente s'atténue. En imagerie cérébrale, une équipe de Stanford a observé, chez des personnes très réceptives à l'hypnose et pendant l'hypnose, une activité diminuée dans le cortex cingulaire antérieur dorsal, une zone liée à la détection de ce qui est important (Jiang et al., *Cerebral Cortex*, 2016-2017). Cette étude ne porte pas sur le tabac.

Ce que dit la recherche sur l'arrêt du tabac

Soyons honnêtes : les preuves sont limitées. La revue Cochrane la plus récente (Barnes et al., 2019) conclut qu'il n'y a pas de preuve fiable que l'hypnothérapie aide à arrêter de fumer davantage que d'autres approches ; s'il y a un bénéfice, il est au plus petit. La qualité des études est faible à très faible. Certaines petites études sont favorables, mais elles comportent des biais.

CE QUE CELA VEUT DIRE POUR VOUS

L'hypnose n'est pas une méthode dont l'efficacité serait établie pour arrêter de fumer. Certaines personnes l'utilisent en complément d'autres aides (accompagnement médical, substituts nicotiniques, soutien comportemental). Elle ne vous contrôle pas et ne vous force à rien.

Comment l'hypnose ericksonienne travaille

L'hypnose ericksonienne, celle que je pratique, travaille en coopération avec vous et non par injonction. Elle s'intéresse aux associations, aux besoins réels et aux ressources que vous avez déjà :

- identifier ce que la cigarette faisait pour vous (calme, pause, appartenance) ;
- installer des ressources internes alternatives : ancrages corporels, états de calme accessibles sans déclencheur chimique ;
- travailler sur la suggestion post-hypnotique, pour répondre différemment aux contextes déclencheurs habituels ;
- s'adapter à votre profil : il n'existe pas de protocole unique.

CHAPITRE

05

Votre programme pratique : *préparer votre arrêt*

Que vous envisagiez une séance d'hypnothérapie ou non, ces actions concrètes vous préparent à l'arrêt. Elles demandent de la curiosité plus que de la volonté.

Étape 1 : comprendre votre profil

Reprenez les 3 profils du chapitre 2. Lequel vous correspond le mieux ? Notez vos 3 situations déclenchantes principales, ce que la cigarette vous apporte vraiment dans chacune, et ce que vous craignez de perdre en arrêtant. Cette liste est la matière première de votre travail.

Étape 2 : évaluer votre dépendance physique

Le score de Fagerström est un test de référence. Il évalue le délai avant la première cigarette, la difficulté à ne pas fumer dans les endroits interdits, la cigarette la plus difficile à supprimer, la quantité quotidienne, la consommation plus forte le matin, et la consommation même malade.

Étape 3 : la cigarette en pleine conscience

Avant votre arrêt, fumez une cigarette différemment : pas vite, pas machinalement, avec une attention totale. Regardez la cigarette, sentez-la, observez la première bouffée, sans jugement. Cette expérience vise à défaire l'automatisme.

Étape 4 : construire votre liste d'alternatives

Pour chaque déclencheur principal, notez une alternative concrète : 3 respirations profondes pour le stress, une pause sans cigarette, un verre d'eau froide après le café, une note dans un carnet pour le sentiment de vide.

Étape 5 : choisir une date, pas une promesse

Choisissez une date précise dans les 14 jours. Dites-le à une personne, notez-le, préparez votre maison (plus de cigarettes, plus de briquets visibles). L'environnement compte autant que la décision.

Score de Fagerström : grille simplifiée

Question	0 point	1 point	2 points	3 points
Première cigarette après le réveil ?	Après 60 min	31-60 min	6-30 min	Dans les 5 min
Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits ?	Non	Oui		
Cigarette la plus difficile à supprimer ?	Une autre	La première du matin		
Nombre de cigarettes par jour ?	10 ou moins	11 à 20	21 à 30	31 ou plus
Fumez-vous plus le matin ?	Non	Oui		
Fumez-vous même malade ?	Non	Oui		

Interprétation (grille de la Haute Autorité de santé, 2014, d'après Heatherton et al., 1991) :

- Score 0 à 2 : pas de dépendance.
- Score 3 à 4 : dépendance faible.
- Score 5 à 6 : dépendance moyenne.
- Score 7 à 10 : dépendance forte ou très forte ; l'avis d'un médecin ou d'un tabacologue est conseillé avant d'arrêter.

CHAPITRE

06

Quand consulter ? *Ce que l'hypnothérapie peut faire pour vous*

CONSULTEZ UN MÉDECIN EN PREMIER SI

Votre score de Fagerström est élevé (5 ou plus), si vous avez un trouble psychiatrique (dépression, anxiété sévère), ou une maladie cardiovasculaire connue. L'hypnothérapie vient en complément d'un suivi médical, pas en remplacement.

Ce qu'une séance d'hypnothérapie peut apporter

- identifier les besoins réels derrière le comportement (calme, pause, appartenance) et trouver comment les satisfaire autrement ;
- travailler sur les contextes déclenchants, avec des suggestions post-hypnotiques personnalisées ;
- installer des ancrages corporels : des gestes discrets qui rappellent un état de calme, accessible n'importe où ;
- travailler sur la peur du manque, la conviction que « sans cigarette, ce sera insupportable » ;
- accompagner la construction de votre identité de non-fumeur, par l'expérience en transe.

À quoi s'attendre

Un accompagnement pour l'arrêt du tabac se déroule souvent sur quelques séances ; le nombre varie selon les personnes. La première séance comprend un temps d'échange approfondi (anamnèse) et une hypnose personnalisée. Les séances suivantes consolident et travaillent sur des résistances ou des situations difficiles.

Je ne peux pas vous promettre de résultat. Mon engagement : si après 2 ou 3 séances rien n'a bougé pour vous, je vous le dis franchement, et je ne vous propose pas de continuer.

Tarif : première séance de 1 h 30, 90 €. Séances suivantes : 1 heure, 90 €. En présentiel à Paris 4e, ou en visioconférence depuis toute la France : un endroit calme, un casque et une connexion stable suffisent.

CONCLUSION

Votre liberté vous attend

Vous avez maintenant une compréhension plus claire de ce qui se passe quand vous fumez, de ce que la cigarette fait et ne fait pas, et des outils pour aborder l'arrêt différemment.

L'ESSENTIEL À RETENIR

- La dépendance au tabac n'est pas un défaut de caractère : c'est un apprentissage, et ce qui s'apprend peut se réapprendre.
- La volonté seule échoue souvent, parce qu'elle s'attaque à un seul niveau du problème.
- L'hypnose ericksonienne ne vous contrôle pas et ne vous force à rien. Ses effets sur l'arrêt du tabac restent à confirmer par la recherche.

> *« Votre liberté est là, quelque part en vous. Parfois elle a juste besoin d'un peu d'aide pour revenir. »*
>
> Alain Zenatti

Mettre des mots sur ce qui vous retient

J'ai préparé 5 questions. Elles prennent 2 minutes. Vous obtenez tout de suite un décryptage personnalisé : ce qui ressort de vos réponses, et quelques pistes pour la suite. C'est gratuit, sans engagement, et vos réponses restent confidentielles.

Faire mon décryptage

Si vous préférez en parler directement, je vous propose un échange de 15 minutes par téléphone, gratuit. On regarde ensemble si l'hypnose est adaptée à votre situation. Si elle ne l'est pas, je vous le dis.

resalib.fr/p/47325

novahypnose.fr/wa

06 49 35 80 89

contact@novahypnose.fr

16 rue Saint-Antoine, 75004 Paris

Alain Zenatti

Hypnothérapeute

SOURCES ET LIMITES

D’où viennent *les chiffres*

Sources

- Santé publique France, Prévalence du tabagisme en France hexagonale en 2023 parmi les 18-75 ans (31,1 % de fumeurs, 23,1 % de fumeurs quotidiens).
- Hughes J. R., Keely J., Naud S. (2004), *Shape of the relapse curve and long-term abstinence among untreated smokers*, *Addiction* 99(1):29-38. résumé PubMed (3 à 5 % d’abstinence prolongée à 6-12 mois).
- Barnes J. et al. (2019), *Hypnotherapy for smoking cessation*, Cochrane Database of Systematic Reviews, CD001008. synthèse Cochrane.
- Jiang H. et al. (2017), imagerie cérébrale de l’hypnose, Université de Stanford (Spiegel et coll.).

LIMITES

Ce guide propose des pistes de réflexion. Il ne remplace ni un avis médical ni un suivi psychologique ou psychiatrique. La recherche sur l’hypnose et l’arrêt du tabac reste limitée et de faible qualité : le guide le signale plutôt que de généraliser.